

Cuadro Comparativo de Emergencias Cardíacas

A continuación se presenta un cuadro de doble entrada con información detallada y humanizada sobre las principales emergencias cardíacas solicitadas.

Patología	Definición	Fisiopatología	Signos y Síntomas	Diagnóstico	Manejo y Tratamiento Prehospitalario
Insuficiencia Cardíaca Aguda (ICA)	Incapacidad súbita del corazón para bombear sangre adecuadamente, causando congestión pulmonar y/o sistémica.	Disfunción ventricular (izquierda o derecha) → aumento de presión en aurículas → congestión pulmonar o sistémica → disminución del gasto cardíaco.	Disnea, ortopnea, estertores, edema en piernas, piel fría y húmeda, taquicardia, fatiga extrema.	Clínica + oximetría + ECG + PA + historia previa; si disponible: BNP elevado.	Asegurar vía aérea, posición semifowler, oxígeno según necesidad, ventilación con CPAP si disponible, monitorización, evitar sobrecarga de líquidos, nitratos si PA lo permite, traslado inmediato.
Disección Aórtica	Ruptura de la capa interna de la aorta que permite que la sangre se introduzca en la pared, separándola.	Aumento súbito de presión → desgarro íntima → formación de falso lumen → compromiso del flujo a órganos vitales.	Dolor torácico "desgarrante" irradiado a espalda, palidez, sudoración, diferencias de pulsos, síncope, hipotensión.	Clínica + PA en ambos brazos + ECG para descartar IAM; si disponible: eco FAST cardíaco.	No administrar líquidos agresivamente, manejo del dolor, control de PA si es severamente alta, oxígeno, no movilizar excesivamente, traslado urgente como prioridad absoluta.
Taponamiento Cardíaco	Acumulación de líquido en el pericardio que comprime el corazón e impide su llenado adecuado.	Aumento de presión pericárdica → compresión del corazón → disminución del retorno venoso → shock obstructivo.	Triada de Beck: hipotensión, ingurgitación yugular, ruidos cardíacos apagados. Además: disnea, taquicardia, ansiedad, piel fría.	Clínica + evaluación de yugulares + ruidos cardíacos; si disponible: eco FAST muestra derrame pericárdico.	Oxígeno, mantener perfusión con bolos pequeños solo si hay shock, evitar ventilación con presión excesiva, preparar traslado urgente para pericardiocentesis definitiva.

Patología	Definición	Fisiopatología	Signos y Síntomas	Diagnóstico	Manejo y Tratamiento Prehospitalario
Edema Agudo de Pulmón (EAP)	Acumulación súbita de líquido en los alvéolos que impide el intercambio gaseoso.	Presión elevada en aurícula/ventrículo izquierdo → salida de líquido hacia los alvéolos → hipoxemia severa.	Disnea severa, tos con espuma rosada, crepitantes, ansiedad, sudoración, cianosis, taquicardia.	Evaluación clínica, SpO ₂ baja, taquipnea, signos de congestión pulmonar.	Posición de Fowler, oxígeno alto flujo, CPAP si disponible, nitratos si PA lo permite, evitar líquidos, monitorizar continuamente y trasladar.